

11 자궁경부암(Cervical Cancer)

1. 고식적요법(palliative)

연번	항암요법	투여대상	투여단계
1	'ifosfamide + carboplatin' 또는 'ifosfamide + cisplatin' (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	재발성 또는 전이성 자궁경부암	1차 이상
2	cisplatin (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)		
3	cisplatin + fluorouracil (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)		
4	carboplatin (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)		
5	carboplatin + fluorouracil (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)		
6	paclitaxel + cisplatin (제2006-6호: 2006.8.1, 개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	가. 재발성, 전이성(stage IV) 나. stage IB2 이상인 자궁경부암 중 다음의 조건 중 한 가지 이상 해당되는 경우 ① 수술 후 골반 림프절(pelvic LN) 양성 ② 수술 후 대동맥 주위 림프절 (para-aortic LN) 양성 ③ 수술 후 parametrium 양성 ※ 연번 9의 단독요법의 경우 'platinum' 약제를 사용하기 관련한 경우에 사용 시 요양급여를 인정함	1차 이상
7	paclitaxel + carboplatin (제2006-6호: 2006.8.1, 개정 제2022-190호: 2022.8.1.)		
8	paclitaxel + ifosfamide (제2006-6호: 2006.8.1, 개정 제2022-190호: 2022.8.1.)		
9	paclitaxel (제2006-6호: 2006.8.1, 개정 제2022-190호: 2022.8.1.)		
10	topotecan + cisplatin (제2007-3호: 2007.4.1, 개정 제2010-12호: 2010.12.15, 개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	재발성, 전이성(stage IV)	1차 이상

연번	항암요법	투여대상	투여단계
11	bevacizumab + paclitaxel + cisplatin (제2015-161호: 2015.8.1, 개정 제2015-314호: 2016.1.1, 개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	지속성(persistent)*, 재발성 또는 전이성(stage IVB) * ‘지속성(persistent)’은 방사선 치료 후 3개월에 질환이 완전 관해(completely regression)되지 않는 경우를 의미함	1차
12	bevacizumab + paclitaxel + carboplatin (제2024-219호: 2024.10.1.)		
13	topotecan (제2024-202호: 2024.9.1.)	재발성 또는 전이성(stage IV) 자궁경부암	2차 이상
14	pembrolizumab ^{주1} + paclitaxel + cisplatin ± bevacizumab (제2025-272호: 2026.1.1.)	PD-L1 발현 양성(CPS≥1 ^{주2})이며 수술 또는 방사선 치료가 부적합한 지속성(persistent)*, 재발성 또는 전이성(IVB) 자궁경부암 * ‘지속성(persistent)’은 방사선 치료 후 3개월에 질환이 완전 관해(completely regression)되지 않는 경우를 의미함 ※ 이전 PD-1 inhibitor 등 면역관문억제제 치료를 받지 않은 경우에 한함	1차
15	pembrolizumab ^{주1} + paclitaxel + carboplatin ± bevacizumab (제2025-272호: 2026.1.1.)		

주1. 면역관문억제제(nivolumab, pembrolizumab 등)는 예상치 못한 부작용 발생 등의 긴급 상황에 대응 가능한 의료기관에서 항암치료요법에 대한 지식과 경험이 충분한 의사에 의해 투여되어야 하며, 요양급여 실시 현황 등에 관한 자료를 건강보험심사평가원장에게 제출하여야 한다.

- 급여인정기관: 다음의 한 가지 이상에 해당하는 기관 중 상근하는 혈액종양내과, 감염 또는 내분비내과, 병리과 전문의가 각 1인 이상인 기관

〈 다 음 〉

- ① ‘응급의료에 관한 법률’에 따른 지역응급센터 이상의 기관
- ② ‘암관리법’에 따른 암센터
- ③ ‘방사선 및 방사성 동위원소 이용진흥법’에 따라 설립된 한국원자력의학원의 사업에 의한 요양기관

- 급여인정기간: 1년까지(단, 질병진행시 중단) 급여인정 하되, 1년 내에 최적의 투여기간에 대한 임상결과 미 발표 시 자동 연장하여 최대 2년으로 함.
- 투여대상: PD-L1 발현율 등의 biomarker를 활용하여 투여대상을 선정하되, 세부 암종별 특성에 따라 달리 적용할 수 있음.
- 사후관리: 요양기관에서 제출한 급여실시내역을 활용하여 효과 및 부작용에 대한 모니터링을 실시할 수 있음.

주2. IHC 22C3 pharmDx assay